Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Anaurilândia
Vara Única

Processo nº 0800701-12.2024.8.12.0022
Classe: Procedimento Comum Cível - Padronizado
Autor:Sebastião Batista de Oliveira
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul e outro

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência movida por Sebastião Batista de Oliveira em face do Município de Anaurilândia e do Estado de Mato Grosso do Sul, partes já qualificadas nos autos.

Alegou ser portador de insuficiência cardíaca (CID I50.9) e necessitar dos medicamentos Entresto 97/103 mg, Lasix 40 mg, Aldactone 25 mg, Vynaxa 20 mg, Jardiance 25 mg e Concor 10 mg.

Juntou documentos às fls. 11/40.

Parecer do Núcleo de Apoio Técnico parcialmente favorável ao pedido às fls. 44/58.

Manifestação ministerial favorável às fls. 63/64.

Deferida a tutela de urgência às fls. 65/68.

Citados (fls. 87/88 e 90/91), os requeridos apresentaram contestação.

O Estado sustentou, em síntese, ausência de preenchimento dos requisitos previstos no Tema n° 1.234 e inexistência de ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o fornecimento da medicação (fls. 92/100).

Embargos de declaração opostos pelo Estado às fls. 102/103.

Réplica e contrarrazões às fls. 109/115.

O Município contestou às fls. 116/125. Requereu, preliminarmente, a inclusão da União no polo passivo. No mérito, alegou que não foi comprovada a imprescindibilidade dos fármacos pleiteados.

Impugnação à contestação às fls. 134/147.

É o relatório. DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC, pois desnecessária a produção de provas em audiência.

A pretensão da parte requerente é **parcialmente procedente**.

De início, ressalto que o NAT emitiu parecer desfavorável ao

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FRANCISCO SOLIMAN, liberado nos autos em 05/09/2025 às 16:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800701-12.2024.8.12.0022 e código TFSOx1c1.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Anaurilândia
Vara Única

fornecimento dos medicamentos *Hemifumarato de Bisoprolol, Rivaroxabana* e *Empagliflozina* (fl. 57, item XI), já que se trata de pedido de **medicamentos não incorporados** nas listas de dispensação obrigatória pela rede pública (SUS), mas **com registro na ANVISA**. Desse modo, considerando que o valor dos fármacos é inferior a 210 salários mínimos, a **competência** para processar e julgar a causa é da **Justiça Estadual**, conforme decidido pelo **STF** em *repercussão geral* no **RE 1.366.243** (**Tema 1234**).

No mérito, destaco que o STF, também em *repercussão geral*, no julgamento do **RE n. 566.471** (**Tema 6**), pacificando a controvérsia, definiu os **critérios** que devem ser observados, **cumulativamente**, para fornecimento de medicamentos não incorporados nas listas de dispensação obrigatória pela rede pública (RENAME, RESME e REMUNE, entre outras), conforme segue:

> *1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.*
>
> *2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:*
>
> ***a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;***
>
> ***(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;***
>
> ***(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;***
>
> ***(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;***
>
> ***(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e***
>
> ***(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.***
>
> *3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FRANCISCO SOLIMAN, liberado nos autos em 05/09/2025 às 16:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800701-12.2024.8.12.0022 e código TFSOx1c1.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Anaurilândia
Vara Única

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente apolítica pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento,previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS".

Sobre a análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pela rede pública de saúde (SUS), o STF, em *repercussão geral*, no âmbito do **RE 1.366.243** (**Tema 1234**), assim definiu a tese (item IV):

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FRANCISCO SOLIMAN, liberado nos autos em 05/09/2025 às 16:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800701-12.2024.8.12.0022 e código TFSOx1c1.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Anaurilândia
Vara Única

inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise."

Ainda sobre o assunto foram publicadas duas **Súmulas Vinculantes:**

Súmula Vinculante n. 60*: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).*

Súmula Vinculante n. 61*: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).*

Vale lembrar que as teses firmadas em julgamentos com repercussão geral e os enunciados de súmula vinculante são de **reprodução obrigatória** pelos demais órgãos jurisdicionais, conforme dispõe o art. 927, II e III, do CPC.

Feitas essas considerações, entendo que a pretensão da parte autora não merece acolhimento, afinal, não atende aos critérios estabelecidos.

O laudo médico de fl. 13 comprova a doença indicada na inicial (*insuficiência cardíaca – CID I50.9*), ao passo que a incapacidade financeira também está provada, haja vista que o valor total dos medicamentos ultrapassa R$ 700,00 (fl. 24).

Entretanto, entendo que os documentos médicos de fls. 13/17 não são suficientes para comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos e da consequente ineficácia do tratamento dos fármacos fornecidos pelo SUS. Demais disso, não há nos autos nenhum documento que comprove a negativa de fornecimento dos medicamentos pelos requeridos; a eficácia clínica do tratamento pleiteado; tampouco evidência de outros tratamentos disponíveis e nem comprovação da ineficácia de outros métodos já experimentados, inclusive com utilização de medicamentos fornecidos pelo SUS.

O questionário médico de fls. 15/17 informa genericamente que não há medicamento no SUS com a mesma eficácia terapêutica daqueles prescritos (*vide* item 5, fl. 16), porém, o parecer do NAT indicou vários fármacos previstos no Protocolo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FRANCISCO SOLIMAN, liberado nos autos em 05/09/2025 às 16:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800701-12.2024.8.12.0022 e código TFSOx1c1.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Anaurilândia
Vara Única

Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) fornecidos pelo Sistema Único de Saúde para tratamento da patologia que acomete o paciente (item IX, fl. 56).

Veja-se, *in verbis*:

> As Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico e Tratamento da Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida, Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 17 de 18/11/2020, recomenda a utilização dos medicamentos Captopril, Enalapril, Losartana, Metoprolol, Carvedilol, Espironolactona, Furosemida, Hidroclorotiazida, Dinitrato ou Mononitrato de Isossorbida, Hidralazina, Digoxina, Sacubitril + Valsartana. Assim, preconiza-se a substituição de IECA ou ARA II por sacubitril valsartana sódica hidratada em pacientes com IC que satisfaçam as seguintes condições: idade inferior a 75 anos; classe funcional NYHA II; fração de ejeção reduzida (≤35%); BNP > 150 pg/mL ou NT-ProBNP > 600 pg/mL; em tratamento otimizado (uso de doses máximas toleradas dos medicamentos preconizados - IECA ou ARA II, betabloqueadores, espironolactonas e doses adequadas de diuréticos em caso de congestão); sintomáticos (sintomas como dispneia aos esforços, sinais de congestão, piora clínica com internações recentes).
>
> A RENAME 2022 tem padronizado no Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) medicamentos anti-hipertensivos (Captopril, Enalapril, Losartana, Metildopa), bloqueadores canal de cálcio (Anlodipino, Nifedipino, Verapamil), betabloqueadores (Atenolol, Carvedilol, Metoprolol, Propranolol), diuréticos (Espironolactona, Furosemida, Hidroclorotiazida), vasodilatadores (Dinitrato ou Mononitrato de Isossorbida, Hidralazina), antiarrítmicos (Amiodarona, Propafenona), estatina (Sinvastatina), antiagregante plaquetário (Ácido Acetilsalicílico), antiulceroso (Omeprazol).

Portanto, não restou comprovado pela parte autora a impossibilidade de substituição dos medicamentos pleiteados pelos fármacos constantes das listas do SUS, dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, tampouco a ilegalidade do ato de não incorporação dos medicamentos pela CONITEC, ausência ou mora na sua apreciação. Além disso, a parte autora não comprovou a eficácia, efetividade e segurança dos fármacos pleiteados, e nem a negativa dos requeridos no fornecimento dos medicamentos.

A parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC.

Nesse cenário, à luz das teses fixadas pelo Superior Tribunal Federal, não preenchidos todos os requisitos estabelecidos, a improcedência em relação aos medicamentos *Hemifumarato de Bisoprolol*, *Rivaroxabana* e *Empagliflozina* é de rigor.

Assim já decidiu o TJMS:

> *APELAÇÃO CÍVEL − OBRIGAÇÃO DE FAZER − MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO − TRIFLURIDINA − CLORIDRATO DE TIPIRACILA (LONSURF) − FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS − TEMA 1234 E TEMA 06 DA REPERCUSSÃO GERAL − AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FRANCISCO SOLIMAN, liberado nos autos em 05/09/2025 às 16:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800701-12.2024.8.12.0022 e código TFSOx1c1.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Anaurilândia
Vara Única

*REQUISITOS LEGAIS − RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (**TJMS**. Apelação / Remessa Necessária n. 0800647-79.2024.8.12.0011, Coxim, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 11/12/2024, p: 12/12/2024).*

*DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ NO TEMA 106. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O STJ estabelece, no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), que o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS exige a comprovação cumulativa de: (i) laudo médico fundamentado e circunstanciado que ateste a ineficácia dos medicamentos oferecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de custear o tratamento; e (iii) registro do medicamento na ANVISA. 2. No caso concreto, o medicamento pretendido está registrado na ANVISA e o Agravante comprovou sua incapacidade financeira para adquiri-lo. Contudo, não demonstrou, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado, a tentativa e a ineficácia de todos os medicamentos fornecidos pelo SUS. 3. Recurso conhecido e desprovido. (**TJMS**. Agravo Interno Cível n. 0800997-81.2022.8.12.0029, Naviraí, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 09/12/2024, p: 10/12/2024).*

*APELAÇÃO CÍVEL − AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA − MANTIDA. DEMANDANTE PORTADOR DE LOMBALGIA − MEDICAMENTOS PLEITEADOS NÃO INCORPORADOS À RENAME − PARECER DO NATJUS DESFAVORÁVEL − NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE DOS FÁRMACOS. REQUISITOS FIXADOS PELO STJ (TEMA 106) − NÃO PREENCHIDOS. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO TEMA 1234 CORROBORA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. (**TJMS**. Apelação Cível n. 0800541-82.2023.8.12.0034, Glória de Dourados, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Nélio Stábile, j: 29/11/2024, p: 03/12/2024).*

Por outro lado, com relação aos medicamentos *Sacubitril + Valsartana*, *Espironolactona* e *Furosemida*, entendo que a pretensão da parte autora **merece acolhimento.**

Consta da nota técnica de fls. 44/58 que os referidos medicamentos são padronizados na lista RENAME para tratamento de insuficiência cardíaca.

Nesse cenário, a demora irrazoável para o fornecimento do tratamento que a parte autora necessita permite a conclusão de que postergar a concessão do pedido formulado resultaria em risco ao resultado útil do processo e, ao final, à própria

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FRANCISCO SOLIMAN, liberado nos autos em 05/09/2025 às 16:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800701-12.2024.8.12.0022 e código TFSOx1c1.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Anaurilândia
Vara Única

efetividade da jurisdição. Desse modo, superada a argumentação defensiva, entendo que, em momento algum, os requeridos apresentaram justificativas que fossem capazes de eximir sua responsabilidade ante ao fornecimento do direito básico à saúde, que lhe é inerente, por força do texto constitucional.

Em outras palavras, o paciente não pode ser responsabilizado, inclusive com sua própria vida, pela inércia do Estado.

Assim, pelas provas produzidas nos autos, tenho que os medicamentos *Sacubitril + Valsartana*, *Espironolactona* e *Furosemida* são os mais adequados ao tratamento de sua patologia, devendo, portanto, ser garantido o seu fornecimento, justamente no escopo de concretizar a proteção e a promoção da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido:

> APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À MULTA COMINATÓRIA SUSCITADA EMCONTRARRAZÕES REJEITADAS CIRURGIA DEVER CONSTITUCIONAL ART. 196, CF LAUDO MÉDICO PARECER FAVORÁVEL DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE PROCEDIMENTO A SER REALIZADO PELO SUS OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DAS ASTREINTES PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. A saúde é direito fundamental social que está intimamente ligado à vida e à dignidade da pessoa humana e como tal deve sobrepor-se às disposições contidas em uma Lei Ordinária que rege a divisão de competências entre as entidades jurídicas de direito público e ao interesse financeiro do Estado, lato sensu. 2. O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar, isolada ou conjuntamente, no polo passivo que tem por finalidade a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado para pessoas desprovidas de recursos financeiros. 3. A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9.4.2014, DJe de 11.4.2014). 4. Havendo laudo médico informando a doença a qual está acometida a parte, bem como o tratamento indicado para seu quadro clínico, somando-se ao fato de a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FRANCISCO SOLIMAN, liberado nos autos em 05/09/2025 às 16:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800701-12.2024.8.12.0022 e código TFSOx1c1.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Anaurilândia
Vara Única

> União, o Estado e o Município têm o dever de garantir a saúde a todos os que dela necessitam, não há como restringir o alcance de uma norma constitucional (artigo 196), a ponto inviabilizar o exercício de um direito constitucionalmente assegurado. 5. Já no que diz respeito à ampliação do prazo para a realização da cirurgia, entendo que não merece acolhimento o pedido, pois em que pese tratar-se de procedimento eletivo, a paciente aguarda desde 14.04.2014, sendo o prazo de 90 dias suficiente para o cumprimento do procedimento. 6. Não se pode admitir que um interesse financeiro e secundário do Estado se sobreponha ao direito à saúde e à vida, sob pena de violar o princípio da dignidade da pessoa humana, direito consagrado como fundamento da República Federativa do Brasil, bem como causar dano reverso efetivamente maior para o agravado (...). (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0800371-04.2014.8.12.0042, Rio Verde de Mato Grosso, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 06/02/2018, p: 07/02/2018).

De outro lado, as provas também comprovam a precariedade da situação econômica da parte autora (fl. 18), o que a impossibilita de ter acesso ao tratamento sem prejuízo da própria subsistência, estando a depender do fornecimento pelo Estado.

Esclarecidos esses pontos, o direito à saúde decorre do próprio princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, erigido à categoria de fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, CF).

A consagração expressa da dignidade da pessoa humana na Constituição Federal, fruto da nova dogmática desenvolvida a partir do segundo pós-guerra (pós-positivismo), faz com que deixe de ser apenas um valor moral para se converter em um valor tipicamente jurídico, passando a ter normatividade, tornando-se o núcleo axiológico do ordenamento jurídico, a partir da compreensão de que a pessoa é o centro e o fim do direito.

Não bastasse isso, o art. 5º, *caput*, da Constituição Federal discorre que: "*Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade*". Sendo desdobramento do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, pode-se dizer, sem qualquer dúvida, que a saúde é um direito fundamental do cidadão, e, como tal, tem a característica de vincular o Poder Público à sua estrita observância.

O que se está a dizer, sob outro enfoque, é que os direitos fundamentais, por estarem previstos na Constituição Federal, tornam-se parâmetros de organização e de limitação dos poderes constituídos, servindo como verdadeiros "guias" para a atuação do Poder Público, que tem o dever indeclinável de respeitá-los e, ainda, por serem elementos da ordem jurídica objetiva, garantir que terceiros também os respeitem.

Além de configurar-se como direito fundamental e, portanto, de observância obrigatória pelo Estado, a própria Constituição Federal disciplina que a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FRANCISCO SOLIMAN, liberado nos autos em 05/09/2025 às 16:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800701-12.2024.8.12.0022 e código TFSOx1c1.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Anaurilândia
Vara Única

saúde é direito do cidadão e dever do Estado prestá-la, consoante se depreende do art. 196: "*A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação*".

A palavra *Estado* empregada no texto constitucional, a toda evidência (e até por questão de hermenêutica constitucional), deve ser interpretada em seu sentido lato, de modo a entender que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar assistência integral à saúde dos cidadãos (trata-se de um direito fundamental prestacional).

Em outras palavras, pela norma constitucional, há um dever solidário de assistência à saúde, o que significa dizer que **todos os entes políticos, seja qual for a esfera Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, têm responsabilidade solidária no atendimento à saúde da população**.

Logo, afigura-se visível que a pessoa acometida de grave patologia, que necessita de medicamentos de elevado custo, e que não tem condições econômicas para suportar as despesas, tem o direito de receber do Estado (sentido lato) – que, por sua vez, tem o dever de disponibilizar o tratamento médico adequado para sua enfermidade.

Portanto, o pedido formulado nos autos em relação aos medicamentos *Espironolactona, Furosemida e Sacubitril + Valsartana* merece acolhida, convicção esta que decorre da interpretação das normas constitucionais com base na hermenêutica constitucional, da interpretação das leis infraconstitucionais à luz da Constituição e das provas produzidas nos autos, as quais revelam, com clareza solar, a absoluta imprescindibilidade de que o paciente utilize o tratamento prescrito pelo médico.

ISSO POSTO, com fundamento no art. 487, I, do CPC, **julgo parcialmente procedente** a pretensão formulada pelo requerente **Sebastião Batista de Oliveira**, para **condenar** o **Município de Anaurilândia** e o **Estado de Mato Grosso do Sul** a **fornecer** à parte autora, *solidariamente*, em definitivo, *Espironolactona, Furosemida e Sacubitril + Valsartana*, **confirmando-se** os efeitos da tutela de urgência de fls. 65/68 em relação a tais medicamentos.

Revogo a tutela de urgência concedida às fls. 65/68 em relação aos medicamentos *Hemifumarato de Bisoprolol, Rivaroxabana e Empagliflozina*.

Outrossim, em atenção à tese definida pelo STF no RE 855.178, julgado em 23/05/2019, em repercussão geral (tema 793)[1], mesmo sendo solidária a responsabilidade dos entes estatais, registro que o cumprimento da obrigação com relação aos medicamentos *Espironolactona* e *Furosemida* deve ser direcionado ao **Município de Anaurilândia**, incumbindo ao **Estado de Mato Grosso do Sul** o fornecimento do medicamento *Sacubitril + Valsartana* e, ainda, a responsabilidade

[1] *"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FRANCISCO SOLIMAN, liberado nos autos em 05/09/2025 às 16:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800701-12.2024.8.12.0022 e código TFSOx1c1.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Anaurilândia
Vara Única

subsidiária, para o caso de não atendimento daquele, consoante parecer do NAT (fl. 56, item VIII).

Deixo de condenar os requeridos nas custas processuais, ante a isenção conferida à Fazenda Pública (art. 24, I, da Lei Estadual n. 3.779/09).

Nos termos dos arts. 87 e 90 do CPC, e à luz do princípio da causalidade, condeno os requeridos[2] **Município de Anaurilândia** e **Estado de Mato Grosso do Sul**, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual (FUNADEP)[3], os quais fixo em R$ 500,00[4], na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em razão do trabalho desenvolvido, a natureza da demanda e o grau de zelo empregado da causa.

A presente sentença não está sujeita ao reexame necessário, tendo em vista a regra estabelecida no art. 496, § 4º, II, do CPC.

Publique-se. **R**egistre-se. **I**ntimem-se.

Transitada em julgado, arquive-se.

Anaurilândia, datado e assinado digitalmente.

Francisco Soliman
Juiz de Direito em Substituição Legal

---

[2] APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS LITISCONSORTES VENCIDOS - ART. 87 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 87 do CPC, restando vencidos ambos os entes requeridos, deve haver a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, ainda que um desses esteja desobrigado do pagamento. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide. (TJMS. Apelação Cível n. 0801049-11.2020.8.12.0009, Costa Rica, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 29/09/2021, p: 06/10/2021)

[3] STF, RE 1.140.005, repercussão geral, tema 1.002. Tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

[4] É assente na jurisprudência o entendimento de que nas ações movidas contra a Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, considerando que o proveito econômico é inestimável, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC (STJ, AgInt no REsp 1.976.775; TJMS, AC 0800457- 94.2017.8.12.0033 – Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FRANCISCO SOLIMAN, liberado nos autos em 05/09/2025 às 16:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800701-12.2024.8.12.0022 e código TFSOx1c1.